西醫基層醫療服務審查執行會高屏區分會

109 年高屏區大內科審查醫師研討會會議紀錄

會議時間：109 年 11 月 25 日(星期三)中午 12 時 30 分

會議地點：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組 7 樓第一會議室

主席：林組長誓揚

出席人員：大內科審查醫師

列席人員：賴主任委員聰宏、鄭英傑理事長、張維仁理事長、中央健康保險署高屏業務組費用二科、費用三科、黃雅惠、陳幸慧

紀錄：陳幸慧

壹、 主席致詞(略)

貳、 報告事項

一、 依醫療法第 67 條規定略以，醫療機構應建立清晰、詳實、完整之病歷，包含各項檢查、檢驗報告資料及醫事人員執行業務所製作之紀錄等。依醫事檢驗師法第 14 條規定略以，醫事檢驗師檢驗，應製作檢驗結果紀錄，出具檢驗報告，並於檢驗報告上簽名或蓋章。綜上，為了解醫療院所提供醫療照護之適切性、合理性及必要性，醫療院所送審應檢送完整之病歷，該病歷應包含檢驗機構代號名稱及醫事檢驗師姓名。故院所申報的藥品、檢驗或處置，需有符合開立條件或起始治療的病歷與正式檢驗報告或影印本，院所送審時務必備齊相關資料佐證(例如:降血脂藥物、降血糖藥物、病毒性肝炎、降尿酸藥物、心電圖、超音波、內視鏡.....等等)。

二、基層診所按照醫院的診斷處方接續所開立的藥物與檢驗，抽審時務必檢送相關資料佐證，如原醫院的病歷摘要影本、處方籤或藥袋影本、雲端藥歷影本、轉診單影本、健康存摺影本...等等任何能證明的資料;

並需注意檢驗檢查追蹤時程與處方時效(例如:降血脂藥物, PPI, Clopidogrel .....等等)。

三、高屏區以往的審查共識，在沒有重新修改前，全部適用，如果有新的共識與規定，舊版自然失效。

四、為求審查公平性與一致性, 審查醫師執行審查業務必須遵守健保相關支付標準、給付規定、審查注意事項與本分會的審查醫師研討會共識，以避免「該核刪而未核刪」或「不該核刪卻核刪」的情形。

五、重申有關 Vitamin B12 的審查務必遵照藥品給付規定與本區共識(Vit B12 可用於 Diabetic Neuropathy,102 年 8 月 19 日共識), 如附件 1。。

六、重申有關降尿酸藥物 Febuxostat 之審查原則務必遵照藥品給付規定(108/12/01)與本區共識, 如附件 2。

七、有關 30022C Specific Allergen test(Mast test)(過敏原測試)審查原則已歸類在「一般原則」如附件 3(108/3/1),不再分列於各科 。

參、 提案討論

提案一: 有關糖尿病用藥 TZD, DPP4i, SGLT2i 三者互相轉換情形

說明: 符合這三類藥物的給付規定並檢附起始治療的相關病歷與檢驗報告, 經具體詳實記載新的臨床狀況,有轉換的必要時，TZD, DPP4i, SLGT2i 三者得互相轉換。例如:因水腫將 TZD 轉成 DPP4i；或有 CHF,將 DPP4i(或 TZD) 轉成 SGLT2i...等等。

決議:照案通過，如說明段。

提案二: 有關糖尿病用藥 GLP-1 RA 是否可互換？

說明: 原則上符合 GLP-1 RA 藥物給付規定並檢附起始治療的相關病歷與檢驗報告, 得互相轉換; 轉換後治療劑量尊重臨床醫師裁量。

決議：照案通過，如說明段。

提案三:有關 12193C B 型利納肽(B 型利納利尿胜肽)Pro-BNP(BNP)申報與審查

說明: 12193C B 型利納肽(B 型利納利尿胜肽)Pro-BNP(BNP)(800 點)已於 109 年 9 月 1 日起開放表別， 建議申報與審查原則如下:

（1） 適應症：初次檢查限具有心衰竭症狀，理學檢查異常，且心電圖(或胸部 X 光)結果異常，經臨床診斷為 Functional Class III 以上之心臟衰竭。

（2） 治療 1-3 個月後得追蹤檢驗；病情穩定後，每六個月得檢一次。

決議：照案通過，如說明段。

肆、散會：下午 1 時 30 分

附件 1:

第 3 章 代謝及營養劑 Metabolic＆nutrient agents （自 100 年 8 月 1 日生效）

3.2.1.Mecobalamin 製劑:(85/4/1、 100/8/1) 限符合以下條件之一使用：

1. 糖尿病併發周邊神經病變並 具有臨床神經學病徵（須於處 方上敘明)。

2. 經神經科專科醫師診斷或經 神經傳導(NCV) 檢查證實之慢性多發性神經病變(chronic polyneuropathy)。（100/8/1）

附件 2:

第 2 節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs （自 108 年 12 月 1 日生效）

2.11.抗痛風劑 Antigout agents 2.11.1.Febuxostat（如 Feburic）：（101/4/1、 103/3/1、105/8/1、108/12/1）限慢性痛風患者之高尿酸血症使用，且符合以下條件之一：

1.曾使用過降尿酸藥物 benzbromarone 治療反應不佳，尿酸值仍高於 6.0 mg/dL。 （103/3/1）

2.患有慢性腎臟病（eGFR＜45 mL/min/1.73m2 或 serum creatinine≧1.5mg/dL)，或具尿酸性腎臟結石或尿酸性尿路結石或痛風石，或肝硬化之痛風病人。（103/3/1、105/8/1、（108/12/1）

3.痛風石病人使用時需於病歷上詳細記載部位(需有照片或 X 光攝影檢查)及醫療理由。（108/12/1）

附件 3:

西醫基層醫療費用審查注意事項, 壹、一般原則：

二十七、過敏原測試 MAST allergy test 審查原則：(108/3/1)

1. 申報 IgE 檢驗，如為 20 歲以上之個案，應註明過敏病史、臨床症狀及嚴重度，申報件數異常且多為老年案件者應嚴審。
2. 除年齡、嗜酸性白血球數考量外或 IgE (12031C)大於其標準值或過敏原檢驗(定性) (30021C)異常時，方得執行特異過敏原免疫檢驗(30022C)，以兩年內未實施者為原則。
3. 陽性率不宜低於 60%，陽性率低於 80%者應嚴審